

Lectura ejecutiva | SE 25-34 de 2026

Durante las últimas diez semanas transcurridas, la señal dominante es la aceleración de dengue. Las IRA aumentan de forma sostenida y muestran presión asistencial pediátrica, aunque sus acumulados no describen por sí solos la intensidad semanal.

Dengue

4 172

+196% desde SE 24

IRAG

6 252

+35,9% desde SE 24

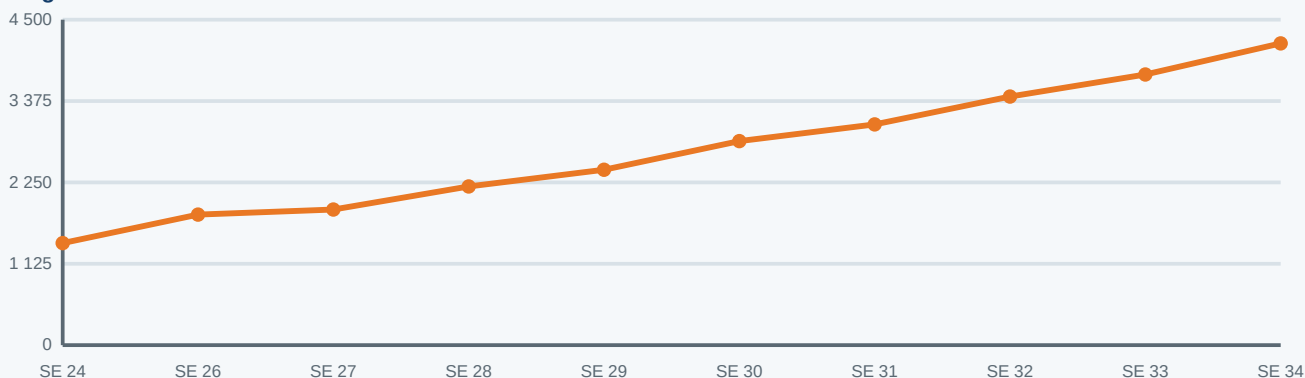
Malaria

79

24 transmisión local

Dengue acumulado

casos notificados

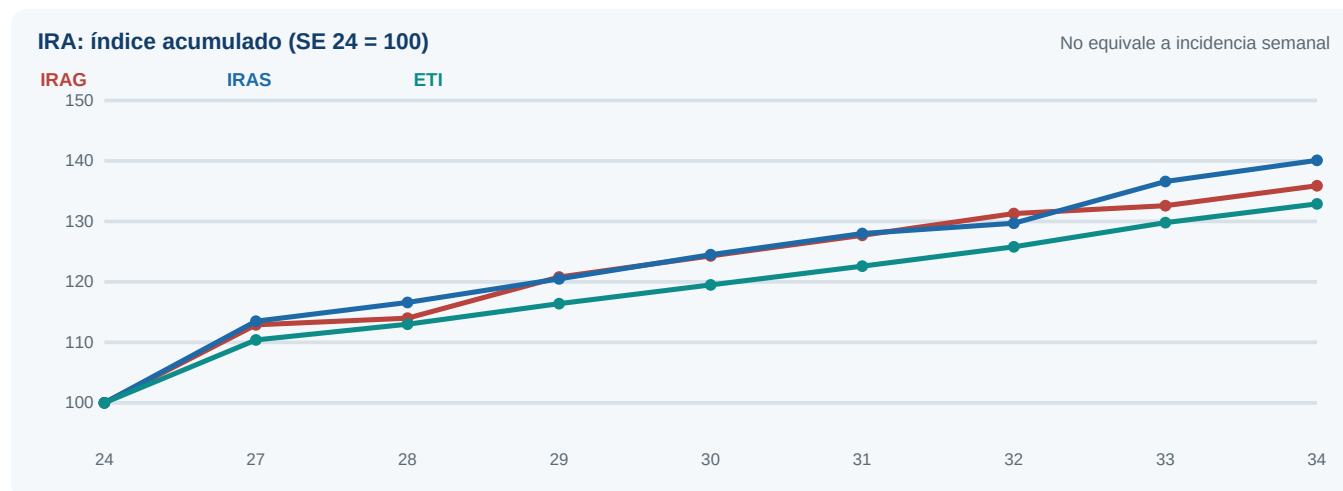


Vectores: qué está ocurriendo

- **Dengue.** Aumentó 2 761 casos entre SE 24 y SE 34. El último incremento publicado fue +430 casos; Central Norte lidera en número y Pacífico Central en tasa.
- **Chikungunya.** Pasó de 21 casos en SE 26 a 300 en SE 34. Chorotega concentra la mayor tasa; requiere vigilancia paralela y diagnóstico diferencial.
- **Malaria.** El aumento es focalizado: 79 casos en total y 24 de transmisión local en SE 34, concentrados en Crucitas-Llano Verde. Hay importados y clasificaciones pendientes.

Evolución de los acumulados

Entre SE 24 y SE 34, las IRAG aumentaron 35,9%, las IRAS 40,1% y las ETI 32,9%. El gráfico convierte cada serie en un índice con base 100 para permitir comparación visual entre magnitudes muy diferentes.



Interpretación epidemiológica

- **IRAG.** La tendencia nacional es ascendente y el patrón por edad se mantiene: niños de 1-4 años y mayores de 75 años concentran más casos. El HNN reportó canal de IRAG en alarma.
- **Atención pediátrica.** Al 9 de septiembre se notificaron 76 pacientes respiratorios hospitalizados en el HNN y 113% de ocupación reportada. Esto exige lectura asistencial, no solo de acumulados nacionales.
- **Circulación viral.** En SE 35 predominó rinovirus, seguido de VRS y COVID-19. La carga no debe atribuirse a un único virus ni extrapolarse a todas las edades.

Precaución de lectura

El salto de IRAS entre SE 32 y SE 33 (+44 412 acumulados) puede incluir consolidación o rezago de notificación. Los acumulados no equivalen a incidencia semanal ni prueban un cambio causal.

Método

- **Ventana.** Se analizaron SE 25-34 de 2026. Para calcular cambio acumulado de diez semanas se usa SE 24 como línea basal.
- **Fuentes.** Boletines epidemiológicos N.º 24 a N.º 33 de 2026 del Ministerio de Salud; cifras nacionales notificadas.
- **Indicadores.** Dengue, chikungunya y malaria para vectores; IRAG, IRAS y ETI para IRA. Se conservaron las semanas específicas de cada indicador.
- **Cálculo.** Variación porcentual = $(\text{acumulado final} / \text{acumulado basal} - 1) \times 100$. Los gráficos muestran acumulados oficiales, no tasas ni estimaciones propias.

Límites que condicionan las conclusiones

- No se publicó un punto independiente de IRA para SE 25-26 en los boletines revisados; no se imputaron valores.
- Los datos son preliminares y el Ministerio advierte rezagos de notificación, especialmente en cortes recientes.
- Malaria incluye casos importados, recaídas y clasificaciones en investigación; no debe interpretarse el total como transmisión local.
- El reporte no permite atribuir cambios a clima, control vectorial, conducta o un agente viral específico.

Prioridades inmediatas

- 1 Intensificar control vectorial y búsqueda de casos en Pacífico Central, Central Norte, Orotina, Alajuela, Grecia y La Cruz.
- 2 Sostener vigilancia focalizada de malaria en Crucitas-Llano Verde, separando transmisión local de importación.
- 3 Preparar capacidad pediátrica respiratoria y vigilancia de IRAG en personas mayores de 75 años.
- 4 Revisar semanalmente datos recientes antes de comunicar tendencias, distinguiendo cambios epidemiológicos de rezagos de reporte.

Referencias operativas

Ministerio de Salud de Costa Rica, Dirección de Vigilancia de la Salud. Boletines Epidemiológicos N.º 24-33 de 2026 (julio-septiembre). Vectores: pp. 3-10; IRA: pp. 16-31, según boletín. Consulta y corte: 16 de septiembre de 2026.

Transparencia sobre uso de IA

Se utilizó IA generativa como apoyo para organizar contenidos y diseño preliminar. Las fuentes, los cálculos, el análisis y la versión final fueron revisados y validados por el autor. La IA no constituye fuente de datos ni reemplaza la responsabilidad profesional.